

保険者機能強化推進交付金等 評価結果の取りまとめと第10期への反映

構成3町の3か年の評価結果を推移・全国との比較・未得点項目の3つの側から整理し、第10期計画への反映の可否を判定したものです。評価は市町村単位で行われ、広域連合の行に得点はありません。本表では当広域連合及び構成3町を単位として整理しています。

区分	内容	備考
作成の経緯	令和8年9月28日のご依頼により、交付金について整理した内容を1冊に取りまとめたものです。	推移分析・同様の構成の団体との比較・必要項目の洗い出しと対応可否の判定・計画素案等との紐付けの4つを扱います。
出典	「令和8年度保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金（市町村分）に係る評価指標」（42頁）及び「同（市町村分）に係る全国集計結果」令和6年度・令和7年度・令和8年度	いずれも発注者よりご提供いただいたものです。
評価の単位	評価は市町村単位で行われます。保険者は大雪地区広域連合ですが、公表資料の広域連合の行に得点はなく、構成3町それぞれの行に記載があります。	したがって町により得点が分かれます。
年度の対応	令和8年度の交付金は令和8年度の評価指標により評価され、評価の対象は令和7年度に実施した取組です。	第10期の初年度（令和9年度）の交付金は、令和8年度の取組を評価します。
全国該当率	評価指標の明細列ごとに、全国1,741市町村のうち当該列に得点のある市町村の割合を算定したものです。	「全国の多くの市町村が実施している取組でありながら当区域が得点していないもの」を見つけるために用います。
他団体の計画を参照しないこと	他の保険者が策定した計画を参照して必要項目を導くことは行っていません。他団体の資料は成果品に用いず、記載の信用も行わないというご指示によるものです。	代わりに、評価指標の原典に示された明細列と全国該当率により「全国の標準」を導いています（07シート）。
同様の構成の団体との比較	全国集計には広域連合・一部事務組合の行があります（名称が市・区・町・村で終わらない行）。団体の行に得点はありませんが、直後に続く構成市町村の行から構成を読み取れるため、構成市町村の得点の平均により比べられます。	38団体・205市町村を割り当て、令和6年度から令和8年度までの3か年で比べました（06シート）。団体名を成果品に掲げることの可否は確認事項No.168です。
得点0の意味	得点0が「取組がない」のか「取組はあるが要件を満たさない」のか「報告していない」のかは、公表資料から判別できません。	評価調書によるご確認をお願いします（確認事項No.6）。
施策への位置づけ	第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するもので、得点のみを理由とするものではありません。	本表は判断の材料を示すものです。

シートの構成

シート	扱うもの	主な結論
01_3か年の推移	3町の得点・全国での位置の3か年の動き	得点は横ばい、全国が伸びたため位置は下がった
02_改善している箇所	大項目別に令和6年度から増えたもの	14項目。医療情報との突合が最も大きい
03_要改善箇所	大項目別に減ったもの・全国との差の大きい指標群	14項目。在宅医療・介護連携が最も弱い
04_大項目別の推移一覧	53項目の3か年の得点	全件を掲げる
05_全国・北海道との比較	指標群別の対全国比	23区分
06_同様の構成の団体との比較	広域連合・一部事務組合38団体と構成市町村205の3か年の得点	当連合は38団体中36位、町村のみ11団体中10位、北海道内4団体で最下位
07_必要項目_全国の標準からみたもの	全国該当率が高いのに3町とも0点の明細列	38列・17の大項目
08_必要項目_区域内で分かれているもの	3町のうち一部の町のみ得点している明細列	78列。横展開の余地
09_対応可否の判定	17の大項目ごとの可否と要する資料	可4・条件付き12・現時点では不可1
10_計画素案・協議資料・確認事項との紐付け	19施策を介した対応状況	素案の章節・確認事項No.と対で示す
11_自己点検	本表の内的整合の点検	

3か年の推移（全体像）

推進・支援合計の得点と、全国1,741市町村の中での位置を3か年で並べたものです。得点そのものはほぼ横ばいですが、全国の平均が上がっているため、全国での位置は下がっています。

年度	町	推進合計	支援合計	推進・支援合計	全国平均	北海道平均	対全国比%	全国での位置%	見方
令和6年度	東川町	160	156	316	422.4	413.6	74.8	15.0	
令和6年度	美瑛町	164	148	312	422.4	413.6	73.9	14.3	
令和6年度	東神楽町	170	198	368	422.4	413.6	87.1	28.3	
令和7年度	東川町	172	148	320	435.0	416.5	73.6	11.9	
令和7年度	美瑛町	167	141	308	435.0	416.5	70.8	9.4	
令和7年度	東神楽町	182	196	378	435.0	416.5	86.9	27.0	
令和8年度	東川町	169	146	315	454.9	432.6	69.2	6.7	3か年で1点下がり、全国での位置は15.0%から6.7%へ下がった
令和8年度	美瑛町	167	141	308	454.9	432.6	67.7	6.0	3か年で4点下がり、全国での位置は14.3%から6.0%へ下がった
令和8年度	東神楽町	182	197	379	454.9	432.6	83.3	20.5	3か年で11点上がったが、全国での位置は28.3%から20.5%へ下がった

3町平均と全国・北海道の動き

年度	3町平均	全国平均	北海道平均	対全国比%	前年度からの3町平均の動き	同 全国平均の動き	集計対象		
令和6年度	332.0	422.4	413.6	78.6			1,741市町村		
令和7年度	335.3	435.0	416.5	77.1	+3.3	+12.6	1,741市町村		
令和8年度	334.0	454.9	432.6	73.4	-1.3	+19.9	1,741市町村		

【読み取り】3町平均は令和6年度332.0点から令和8年度334.0点へ+2.0点の変化にとどまる一方、全国平均は422.4点から454.9点へ+32.5点上がりました。このため対全国比は78.6%から73.4%へ下がり、全国での位置（下位からの割合）も東川町15.0%→6.7%、美瑛町14.3%→6.0%、東神楽町28.3%→20.5%と下がっています。得点が下がったのではなく、全国が伸びたことにより相対的な位置が下がったものです。取組を現状のまま続けると、位置はさらに下がります。

【交付金額との関係】交付金は得点に応じて配分されるため、全国での位置は財源の差として実質的な意味を持ちます。計画本文に順位を載せるかどうかは確認事項No.70です（令和8年9月3日のご指示により、評価結果は計画本文ではなく策定委員会資料として整理しています。No.71）。

改善している箇所（大項目別・令和6年度→令和8年度）

評価指標の大項目（53項目）のうち、3町計の得点が令和6年度から増えたものです。指標群の別を併せて示します。成果指標群は取組ではなく結果を測るものであり、取組の改善とは区別して読む必要があります。

No	交付金	指標群	大項目	配点(3町計)	R6	R7	R8	R6→R8	東川R8	美瑛R8	東神楽R8	見方
1	推進	活動	医療情報との突合の実施状況	48	0	48	48	+48	16	16	16	令和7年度から3町とも満点。給付適正化の主要3事業の一つ
2	推進	成果	短期的な要介護度の変化（要介護3～5）	120	30	15	60	+30	20	20	20	成果指標。年度による振れが大きい
3	支援	成果	短期的な要介護度の変化（要介護3～5）	120	30	15	60	+30	20	20	20	成果指標。年度による振れが大きい
4	推進	成果	健康寿命延伸の状況	120	15	45	30	+15	10	10	10	成果指標。年度による振れが大きい
5	支援	成果	健康寿命延伸の状況	120	15	45	30	+15	10	10	10	成果指標。年度による振れが大きい
6	支援	活動	人生の最終段階における支援の実施状況	48	0	12	14	+14	2	0	12	令和6年度0点から着手した
7	支援	活動	認知症地域支援推進員の業務の状況	36	6	18	15	+9	6	0	9	東川町・東神楽町が得点。美瑛町は0点
8	支援	活動	生活支援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合	12	5	9	12	+7	4	4	4	令和8年度に3町とも満点
9	支援	活動	入退院支援の実施状況	48	0	0	6	+6	2	2	2	令和8年度に初めて得点した。なお0点の列が3つある（07シート）
10	推進	体制・取組	庁内・庁外における連携体制	102	72	76	76	+4	26	22	28	
11	支援	体制・取組	アウトリーチ等の取組状況	27	6	8	9	+3	1	1	7	
12	支援	活動	地域包括支援センター3職種の配置状況	12	7	8	8	+1	2	3	3	
13	支援	活動	ポイント事業への参加率	12	1	2	2	+1	0	1	1	
14	支援	活動	心身・認知機能維持・改善者の割合	12	5	5	6	+1	1	3	2	
新	支援	体制・取組	難聴高齢者の早期発見・早期介入	60	—	20	20	新設	10	0	10	令和8年度に新設された項目（令和6年度の「認知症初期集中支援チームの活動状況」に代わるもの）

【読み取り】改善は14項目です。このうち取組を測る指標群（体制・取組指標群・活動指標群）は10項目、成果指標群は4項目です。成果指標群は要介護度の変化や健康寿命など結果を測るもので、年度による振れが大きく、取組の改善とは区別して読む必要があります。取組の側で最も大きいのは医療情報との突合（+48点）で、給付費適正化の主要3事業の一つです。

要改善箇所（大項目別に下がったもの・指標群別に全国との差の大きいもの）

① 3町計の得点が令和6年度から減った大項目と、② 指標群別に対全国比の低いものを掲げます。②は下がってなくても全国との差が大きいものであり、改善の余地が大きい区分です。

① 令和6年度から下がった大項目

No	交付金	指標群	大項目	配点(3町計)	R6	R7	R8	R6→R8	東川R8	美瑛R8	東神楽R8	見方
1	推進	成果	短期的な要介護度の変化（要介護１・２）	120	45	45	0	-45	0	0	0	成果指標。令和8年度は3町とも0点
2	支援	成果	短期的な要介護度の変化（要介護１・２）	120	45	45	0	-45	0	0	0	成果指標。令和8年度は3町とも0点
3	推進	成果	長期的な要介護度の変化（要介護３～５）	60	45	30	30	-15	10	10	10	成果指標
4	支援	成果	長期的な要介護度の変化（要介護３～５）	60	45	30	30	-15	10	10	10	成果指標
5	支援	体制・取組	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	75	30	15	16	-14	8	4	4	3町のいずれも1列以上が0点。町により得点する列が異なる
6	推進	体制・取組	介護人材の確保・定着の取組状況	90	48	42	42	-6	18	12	12	町により得点する列が異なる（08シート）
7	支援	活動	通いの場への参加率	24	9	9	4	-5	0	0	4	参加率の水準による指標。総合事業ベースで3.53％
8	推進	体制・取組	給付費適正化事業の取組状況	108	46	42	42	-4	6	22	14	美瑛町のみ得点している列が2つある。全国該当率96.9％の列が3町とも0点（07シート）
9	支援	活動	地域包括支援センター事業評価の達成状況	36	7	7	3	-4	1	1	1	事業評価は3町とも実施していない。実施すれば得点に結びつく
10	推進	活動	後期高齢者と給付費の伸び率比較	36	21	18	18	-3	9	0	9	
11	支援	体制・取組	介護予防・生活支援の体制整備	27	11	11	8	-3	1	4	3	
12	支援	体制・取組	多様なサービスの活用推進	21	11	9	9	-2	3	3	3	
13	支援	体制・取組	通いの場参加者の健康状態の把握・分析	21	15	14	14	-1	5	2	7	
14	支援	活動	多様なサービスの実施状況	39	10	9	9	-1	3	3	3	

② 指標群別に対全国比の低いもの（令和8年度）

No	交付金	指標群	区分	3町平均	全国平均	北海道平均	対全国比％	全国との差	東川	美瑛	東神楽	見方
1	推進	Ⅲ（ii）計	活動	1.0	8.2	6.7	12.2	-7.2	3	0	0	介護人材の活動指標。配点そのものから小さい
2	支援	Ⅲ（i）計	体制・取組	23.7	55.5	50.1	42.6	-31.8	21	23	27	在宅医療・介護連携。3町とも0点の明細列が12ある（07シート）
3	推進	Ⅱ（i）計	体制・取組	22.0	50.5	45.5	43.6	-28.5	14	30	22	給付費適正化の方策の策定と取組。第7期給付適正化計画として素案に位置づけ済み
4	支援	Ⅲ（ii）計	活動	6.7	12.8	6.1	52.1	-6.1	4	2	14	
5	支援	Ⅱ（ii）計	活動	7.0	13.3	12.5	52.6	-6.3	6	6	9	
6	支援	Ⅱ（i）計	体制・取組	22.7	37.8	32.8	60.0	-15.1	27	13	28	認知症総合支援。町により得点が分かれる
7	推進	Ⅰ（ii）計	活動	6.0	10.0	8.1	60.0	-4.0	9	0	9	
8	推進	Ⅰ（i）計	体制・取組	33.3	52.3	48.9	63.7	-19.0	28	32	40	計画の進捗管理・評価結果の活用。進捗管理の手順は素案 第1章第6節に定められている
9	支援	Ⅰ（i）計	体制・取組	25.3	37.4	33.8	67.7	-12.1	16	20	40	
10	推進	Ⅱ（ii）計	活動	16.0	18.7	18.1	85.6	-2.7	16	16	16	
11	推進	Ⅲ（i）計	体制・取組	39.3	42.7	40.1	92.1	-3.4	44	34	40	
12	支援	Ⅰ（ii）計	活動	21.0	20.4	20.8	102.9	0.6	17	22	24	

① 令和6年度から下がった大項目

【読み取り】下がった大項目は14項目、うち取組を測る指標群は10項目です。指標群別では支援 目標Ⅲ（ⅰ）体制・取組指標群（在宅医療・介護連携）が対全国比42.6％で最も低く、次いで推進 目標Ⅱ（ⅰ）（給付費適正化）43.6％です。一方、目標Ⅳ成果指標群は対全国比115.3％で全国を上回っています。

大項目別の推移一覧（53項目・3か年）

評価指標の大項目ごとに、3町計の得点の3か年の推移を掲げます。配点は3町計（1町あたりの配点×3）です。成果指標群は選択肢が排他的であり配点の合計が満点を超えるため、得点率は達成度としてではなく町間・年度間の比較に用います。

No	交付金	目標	指標群	大項目	配点(3町計)	R6	R7	R8	R6→R8	東川R8	美瑛R8	東神楽R8	状態
1	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	体制・取組	地域の介護保険事業の特徴	48	48	48	48	+0	16	16	16	横ばい
2	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	体制・取組	事業計画の進捗状況	48	24	24	24	+0	8	8	8	横ばい
3	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	体制・取組	施策の実施状況の把握・改善	48	28	28	28	+0	4	8	16	横ばい
4	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	体制・取組	評価結果の活用	48	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
5	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	活動	今年度の評価点	36	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
6	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	活動	後期高齢者と給付費の伸び率比較	36	21	18	18	-3	9	0	9	低下
7	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	活動	PFS委託事業数	36	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
8	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	体制・取組	給付費適正化方策の策定状況	96	24	24	24	+0	8	8	8	横ばい
9	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	体制・取組	給付費適正化事業の取組状況	108	46	42	42	-4	6	22	14	低下
10	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	活動	ケアプラン点検の実施状況	48	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
11	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	活動	医療情報との突合の実施状況	48	0	48	48	+48	16	16	16	改善
12	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	体制・取組	介護人材の確保・定着の取組状況	90	48	42	42	-6	18	12	12	低下
13	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	体制・取組	庁内・庁外における連携体制	102	72	76	76	+4	26	22	28	改善
14	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	活動	介護の仕事の魅力に関する研修の実施状況	36	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
15	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	活動	介護人材の定着・資質向上に関する研修の実施状況	36	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
16	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	活動	介護支援専門員に対する研修の実施状況	36	3	6	3	+0	3	0	0	横ばい
17	推進	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	短期的な要介護度の変化（要介護1・2）	120	45	45	0	-45	0	0	0	低下
18	推進	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	長期的な要介護度の変化（要介護1・2）	60	45	30	45	+0	15	15	15	横ばい
19	推進	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	短期的な要介護度の変化（要介護3～5）	120	30	15	60	+30	20	20	20	改善
20	推進	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	長期的な要介護度の変化（要介護3～5）	60	45	30	30	-15	10	10	10	低下
21	推進	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	健康寿命延伸の状況	120	15	45	30	+15	10	10	10	改善
22	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	データを活用した課題の把握	18	11	11	11	+0	1	4	6	横ばい
23	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	アウトリーチ等の取組状況	27	6	8	9	+3	1	1	7	改善
24	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	介護予防等と保健事業の一体的実施	21	15	15	15	+0	5	3	7	横ばい
25	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	通いの場参加者の健康状態の把握・分析	21	15	14	14	-1	5	2	7	低下
26	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	地域りハビリテーションの推進	21	10	10	10	+0	0	3	7	横ばい
27	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	介護予防・生活支援の体制整備	27	11	11	8	-3	1	4	3	低下
28	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	体制・取組	多様なサービスの活用推進	21	11	9	9	-2	3	3	3	低下

No	交付金	目標	指標群	大項目	配点(3町計)	R6	R7	R8	R6→R8	東川R8	美瑛R8	東神楽R8	状態
29	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	地域包括支援センター3職種の配置状況	12	7	8	8	+1	2	3	3	改善
30	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	地域包括支援センター事業評価の達成状況	36	7	7	3	-4	1	1	1	低下
31	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	個別事例の検討割合	12	9	9	9	+0	3	3	3	横ばい
32	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	通いの場への参加率	24	9	9	4	-5	0	0	4	低下
33	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	ポイント事業への参加率	12	1	2	2	+1	0	1	1	改善
34	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	心身・認知機能維持・改善者の割合	12	5	5	6	+1	1	3	2	改善
35	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	生活支援コーディネーター数	12	10	10	10	+0	3	4	3	横ばい
36	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	生活支援コーディネーターの地域ケア会議への参加割合	12	5	9	12	+7	4	4	4	改善
37	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	活動	多様なサービスの実施状況	39	10	9	9	-1	3	3	3	低下
38	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	体制・取組	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	75	30	15	16	-14	8	4	4	低下
39	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	体制・取組	早期診断・早期対応の体制構築	57	32	32	32	+0	9	9	14	横ばい
40	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	体制・取組	難聴高齢者の早期発見・早期介入	60	—	20	20	新設	10	0	10	新設
41	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	活動	認知症サポーター数	36	6	6	6	+0	0	6	0	横ばい
42	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	活動	認知症サポーターステップアップ講座修了者数	36	0	0	0	+0	0	0	0	3か年0点
43	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	活動	認知症地域支援推進員の業務の状況	36	6	18	15	+9	6	0	9	改善
44	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	体制・取組	在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討	78	33	33	33	+0	11	11	11	横ばい
45	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	体制・取組	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	63	17	17	17	+0	5	7	5	横ばい
46	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	体制・取組	医療・介護関係者間の情報共有	63	21	21	21	+0	5	5	11	横ばい
47	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	活動	入退院支援の実施状況	48	0	0	6	+6	2	2	2	改善
48	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	活動	人生の最終段階における支援の実施状況	48	0	12	14	+14	2	0	12	改善
49	支援	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	短期的な要介護度の変化（要介護1・2）	120	45	45	0	-45	0	0	0	低下
50	支援	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	長期的な要介護度の変化（要介護1・2）	60	45	30	45	+0	15	15	15	横ばい
51	支援	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	短期的な要介護度の変化（要介護3～5）	120	30	15	60	+30	20	20	20	改善
52	支援	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	長期的な要介護度の変化（要介護3～5）	60	45	30	30	-15	10	10	10	低下
53	支援	目標Ⅳ 高齢者がその状況に応じて可能な限り自立した日常生活を営む	成果	健康寿命延伸の状況	120	15	45	30	+15	10	10	10	改善

改善14・低下14・横ばい24（うち3か年とも0点7）・新設1。令和6年度にあって令和8年度にない項目は支援 認知症初期集中支援チームの活動状況。

全国・北海道との比較（指標群別・3か年）

目標別・指標群別に、3町平均と全国平均・北海道平均を並べます。全国は1,741市町村、北海道は179市町村です。対全国比が100を下回るものが全国の平均に届いていない区分です。

区分	R6 3町平均	R6 全国	R6 北海道	R6 対全国 %	R7 3町平均	R7 全国	R7 北海道	R7 対全国 %	R8 3町平均	R8 全国	R8 北海道	R8 対全国 %
推進Ⅰ合計	40.3	56.2	55.0	71.8	39.3	59.4	55.7	66.2	39.3	62.3	57.1	63.1
推進Ⅰ（ⅰ）計	33.3	46.3	45.3	72.0	33.3	49.4	47.4	67.5	33.3	52.3	48.9	63.7
推進Ⅰ（ⅱ）計	7.0	9.8	9.7	71.4	6.0	10.0	8.3	60.0	6.0	10.0	8.1	60.0
推進Ⅱ合計	23.3	59.8	57.9	39.0	38.0	65.4	62.4	58.1	38.0	69.1	63.6	55.0
推進Ⅱ（ⅰ）計	23.3	42.4	40.2	55.0	22.0	47.3	44.1	46.5	22.0	50.5	45.5	43.6
推進Ⅱ（ⅱ）計	0.0	17.5	17.7	0.0	16.0	18.1	18.3	88.4	16.0	18.7	18.1	85.6
推進Ⅲ合計	41.0	41.1	41.7	99.8	41.3	46.6	44.4	88.7	40.3	50.8	46.8	79.4
推進Ⅲ（ⅰ）計	40.0	33.8	35.9	118.3	39.3	38.9	38.2	101.1	39.3	42.7	40.1	92.1
推進Ⅲ（ⅱ）計	1.0	7.2	5.8	13.9	2.0	7.8	6.2	25.6	1.0	8.2	6.7	12.2
推進Ⅳ合計	60.0	48.6	55.8	123.5	55.0	47.9	52.6	114.8	55.0	47.7	54.4	115.3
推進・支援合計	332.0	422.4	413.6	78.6	335.3	435.0	416.5	77.1	334.0	454.9	432.6	73.4
推進合計	164.7	205.7	210.4	80.1	173.7	219.3	215.1	79.2	172.7	230.0	221.9	75.1
支援Ⅰ合計	47.3	51.5	49.7	91.9	48.7	55.3	53.0	88.0	46.3	57.8	54.7	80.2
支援Ⅰ（ⅰ）計	26.3	31.4	29.1	83.9	26.0	35.1	32.2	74.1	25.3	37.4	33.8	67.7
支援Ⅰ（ⅱ）計	21.0	20.1	20.6	104.5	22.7	20.2	20.8	112.2	21.0	20.4	20.8	102.9
支援Ⅱ合計	36.3	54.5	48.5	66.7	30.3	46.5	41.5	65.2	29.7	51.1	45.4	58.1
支援Ⅱ（ⅰ）計	32.3	42.4	38.1	76.3	22.3	33.3	29.6	67.1	22.7	37.8	32.8	60.0
支援Ⅱ（ⅱ）計	4.0	12.1	10.4	33.1	8.0	13.2	11.9	60.6	7.0	13.3	12.5	52.6
支援Ⅲ合計	23.7	62.1	49.3	38.1	27.7	66.1	54.3	41.9	30.3	68.3	56.3	44.4
支援Ⅲ（ⅰ）計	23.7	49.3	42.4	48.0	23.7	53.3	47.9	44.4	23.7	55.5	50.1	42.6
支援Ⅲ（ⅱ）計	0.0	12.8	6.8	0.0	4.0	12.8	6.4	31.2	6.7	12.8	6.1	52.1
支援Ⅳ合計	60.0	48.6	55.8	123.5	55.0	47.9	52.6	114.8	55.0	47.7	54.4	115.3
支援合計	167.3	216.7	203.3	77.2	161.7	215.8	201.4	74.9	161.3	224.9	210.7	71.7

【読み取り】令和8年度に全国平均を上回っているのは推進Ⅳ合計・支援Ⅳ合計（いずれも成果指標群。対全国比115.3％）と支援Ⅰ（ⅱ）活動指標群（102.9％）です。体制・取組指標群はすべて全国平均を下回っています。成果指標（要介護度の変化・健康寿命）は良く、取組の報告の側で差がついている形です。

同様の構成の団体との比較（広域連合・一部事務組合 38団体）

当連合と同じく複数の市町村で構成する広域連合・一部事務組合は全国に38団体あり、205市町村が属しています。交付金は市町村に交付されるため団体の行に得点はなく、構成市町村の得点の平均により比較します。平均は単純平均です（第1号被保険者数で加重した値も併せて掲げます）。令和6年度から令和8年度までの3か年で比べています。

① 団体と構成市町村の割り出し方

No	確かめたこと	結果											
団体の行があること	全国集計は1,779行あり、名称が市・区・町・村で終わらない行が38行ある。いずれも保険者番号を持つ広域連合・一部事務組合である。												
団体の行に得点がないこと	38団体とも推進・支援合計の欄が空欄である。得点のある行は1,741で、全国の市区町村の数と一致する。交付金が市町村に交付されるためである。												
構成市町村が読めること	団体の行の直後に構成市町村の行が続く。構成市町村の行は保険者番号の欄が空欄である（保険者番号は団体が持つ）。次に保険者番号のある行が現れるまでが一つの団体である。												
漏れがないこと	この規則により令和8年度は38団体・205市町村、令和6年度は40団体・210市町村を割り当て、所属の定まらない行は1件もなかった。当連合の構成が東川町・美瑛町・東神楽町となることは既に確認している事実と一致する。												
3か年を通して比べられること	38団体の構成市町村は令和6年度と令和8年度で完全に一致する（市町村コードで照合）。令和6年度にあって令和8年度にない団体が2件ある。												

② 38団体の比較（令和8年度・単純平均の高い順）

順	団体	都道府県	構成	市を含む	R6平均	R7平均	R8平均	R6→R8	加重平均	最低	最高	当連合との差	見方
1	浜田地区広域行政組合	島根県	2	有	572.5	533.5	644.5	+72.0	639.9	632	657	+310.5	
2	大曲仙北広域市町村圏組合	秋田県	3	有	580.3	518.7	604.0	+23.7	599.0	591	621	+270.0	
3	知多北部広域連合	愛知県	4	有	608.8	596.2	586.5	-22.2	584.2	569	612	+252.5	
4	坂井地区広域連合	福井県	2	有	494.5	538.0	582.5	+88.0	587.6	572	593	+248.5	
5	佐賀中部広域連合	佐賀県	5	有	558.2	590.0	576.0	+17.8	561.5	554	611	+242.0	
6	安八郡広域連合	岐阜県	3	—	487.7	498.7	575.3	+87.7	574.1	568	581	+241.3	
7	空知中部広域連合	北海道	6	有	545.5	542.5	563.3	+17.8	566.2	528	615	+229.3	北海道内で最も高い。歌志内市を含む6市町
8	鳥栖地区広域市町村圏組合	佐賀県	4	有	527.5	586.0	556.8	+29.2	560.4	543	568	+222.8	
9	雲南広域連合	島根県	3	有	583.3	556.0	540.7	-42.7	534.0	529	553	+206.7	
10	木曽広域連合	長野県	6	—	452.0	518.8	535.8	+83.8	526.7	494	568	+201.8	
11	杵藤地区広域市町村圏組合	佐賀県	7	有	473.7	472.1	528.7	+55.0	522.6	495	594	+194.7	
12	隠岐広域連合	島根県	4	—	488.8	451.5	520.8	+32.0	498.2	486	549	+186.8	
13	福岡県介護保険広域連合	福岡県	33	有	478.9	522.1	510.3	+31.4	512.7	426	567	+176.3	

① 団体と構成市町村の割り出し方

14	鈴鹿亀山地区広域連合	三重県	2	有	389.0	503.5	505.5	+116.5	509.9	498	513	+171.5	
15	中新川広域行政事務組合	富山県	3	—	539.0	494.0	497.7	-41.3	475.8	463	545	+163.7	
16	紀南介護保険広域連合	三重県	3	有	392.3	385.3	496.7	+104.3	492.6	479	506	+162.7	
17	大里広城市町村圏組合	埼玉県	3	有	438.3	474.3	493.7	+55.3	509.2	435	557	+159.7	
18	日高中部広域連合	北海道	2	—	411.5	471.5	492.0	+80.5	473.8	463	521	+158.0	構成2町。当連合同じく町村のみで構成する
19	島原地域広城市町村圏組合	長崎県	3	有	603.7	583.0	488.7	-115.0	488.4	480	505	+154.7	
20	砺波地方介護保険組合	富山県	3	有	525.3	512.3	481.7	-43.7	482.3	475	488	+147.7	
21	南部箕蚊屋広域連合	鳥取県	3	—	498.3	441.7	456.7	-41.7	458.6	451	464	+122.7	
22	北アルプス広域連合	長野県	5	有	391.4	428.0	453.4	+62.0	442.1	431	488	+119.4	
23	後志広域連合	北海道	16	—	399.9	421.1	436.4	+36.6	452.2	340	535	+102.4	構成16町村。当連合同じく町村のみで構成する
24	新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合	富山県	3	有	409.7	412.0	434.0	+24.3	439.9	421	458	+100.0	
25	紀北広域連合	三重県	2	有	382.5	459.0	430.5	+48.0	428.9	408	453	+96.5	
26	二戸地区広域行政事務組合	岩手県	4	有	383.5	447.0	426.2	+42.8	416.0	392	439	+92.2	
27	諏訪広域連合	長野県	6	有	462.0	428.7	418.7	-43.3	429.7	367	447	+84.7	
28	東三河広域連合	愛知県	8	有	410.5	344.4	401.2	-9.2	414.0	327	459	+67.2	
29	揖斐広域連合	岐阜県	3	—	393.3	377.3	390.0	-3.3	391.6	321	425	+56.0	
30	久慈広域連合	岩手県	4	有	368.5	357.2	375.0	+6.5	427.7	305	475	+41.0	
31	みよし広域連合	徳島県	2	有	291.0	342.0	374.0	+83.0	380.6	356	392	+40.0	
32	もとす広域連合	岐阜県	3	有	369.0	382.7	371.3	+2.3	361.2	309	425	+37.3	
33	盛岡北部行政事務組合	岩手県	3	有	328.7	313.0	354.0	+25.3	356.9	345	360	+20.0	
34	中芸広域連合	高知県	5	—	303.4	291.6	352.0	+48.6	351.7	348	354	+18.0	
35	沖縄県介護保険広域連合	沖縄県	29	有	276.9	328.9	345.2	+68.3	381.4	191	495	+11.2	
36	大雪地区広域連合	北海道	3	—	332.0	335.3	334.0	+2.0	332.2	308	379	—	当連合。3か年ほぼ横ばいで、団体の平均が上がる中で位置が下がった
37	一関地区広域行政組合	岩手県	2	有	345.5	342.0	315.5	-30.0	316.8	314	317	-18.5	
38	邑智郡総合事務組合	島根県	3	—	351.7	328.3	291.3	-60.3	268.9	231	337	-42.7	

【読み取り】当連合は38団体中36位です（令和6年度は34位）。38団体の平均は令和6年度443.4点→令和7年度450.7点→令和8年度466.9点と+23.5点上がっているのに対し、当連合は332.0点→335.3点→334.0点で+2.0点にとどまり、団体の側でも同じ傾きの差が出ています。3か年の伸びは38団体中27位です（下がった団体が11件あります）。構成市町村の最低は308点・最高は379点で、区域内の開きは71点です。

③ 同様の構成（町村のみで構成する団体）との比較

順	団体	都道府県	構成	市を含む	R6平均	R7平均	R8平均	R6→R8	加重平均	最低	最高	当連合との差	見方
---	----	------	----	------	------	------	------	-------	------	----	----	--------	----

① 団体と構成市町村の割り出し方

1	安八郡広域連合	岐阜県	3	—	487.7	498.7	575.3	+87.7	574.1	568	581	+241.3	
2	木曽広域連合	長野県	6	—	452.0	518.8	535.8	+83.8	526.7	494	568	+201.8	
3	隠岐広域連合	島根県	4	—	488.8	451.5	520.8	+32.0	498.2	486	549	+186.8	
4	中新川広域行政事務組合	富山県	3	—	539.0	494.0	497.7	-41.3	475.8	463	545	+163.7	
5	日高中部広域連合	北海道	2	—	411.5	471.5	492.0	+80.5	473.8	463	521	+158.0	構成2町。当連合と同じく町村のみで構成する
6	南部箕蚊屋広域連合	鳥取県	3	—	498.3	441.7	456.7	-41.7	458.6	451	464	+122.7	
7	後志広域連合	北海道	16	—	399.9	421.1	436.4	+36.6	452.2	340	535	+102.4	構成16町村。当連合と同じく町村のみで構成する
8	揖斐広域連合	岐阜県	3	—	393.3	377.3	390.0	-3.3	391.6	321	425	+56.0	
9	中芸広域連合	高知県	5	—	303.4	291.6	352.0	+48.6	351.7	348	354	+18.0	
10	大雪地区広域連合	北海道	3	—	332.0	335.3	334.0	+2.0	332.2	308	379	—	当連合。3か年ほぼ横ばいで、団体の平均が上がる中で位置が下がった
11	邑智郡総合事務組合	島根県	3	—	351.7	328.3	291.3	-60.3	268.9	231	337	-42.7	

【読み取り】市を含まず町村のみで構成する団体は11団体あり、当連合はその中で10位です。11団体の平均は443.8点で、当連合は109.8点低くなっています。令和6年度から下がったのは4団体だけです。町村のみで構成することが低位の理由にはなっていません。

④ 北海道内の団体

順	団体	都道府県	構成	市を含む	R6平均	R7平均	R8平均	R6→R8	加重平均	最低	最高	当連合との差	構成市町村
1	空知中部広域連合	北海道	6	有	545.5	542.5	563.3	+17.8	566.2	528	615	+229.3	歌志内市・奈井江町・上砂川町・浦臼町・新十津川町・雨竜町
2	日高中部広域連合	北海道	2	—	411.5	471.5	492.0	+80.5	473.8	463	521	+158.0	新冠町・新ひだか町
3	後志広域連合	北海道	16	—	399.9	421.1	436.4	+36.6	452.2	340	535	+102.4	島牧村・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・共和町・泊村・神恵内村・稚内町・士亜町・久本町・赤井川村
4	大雪地区広域連合	北海道	3	—	332.0	335.3	334.0	+2.0	332.2	308	379	—	東川町・美瑛町・東神楽町

【読み取り】北海道内の団体は4件で、当連合は3か年とも最も低い水準です。最も高い空知中部広域連合とは令和8年度で229.3点の差があります。後志広域連合・日高中部広域連合は当連合と同じく町村のみで構成しますが、いずれも当連合を上回っています。

⑤ なお確かめられていないこと

No	事項	内容											
令和7年度の内訳	令和7年度は合計得点と順位のみである（令和8年度の集計に併載されている）。推進と支援の別、目標別・大項目別の内訳は令和7年度の原本を要する。3か年の合計得点の比較はできている。												
令和6年度にあって令和8年度にない	本荘由利広域市町村圏組合（秋田県）とくすのき広域連合（大阪府）は令和6年度の集計にあり令和8年度の集計にない。3か年を通して比べられるのは38団体である。38団体の構成市町村は令和6年度と令和8年度で完全に一致する。												

① 団体と構成市町村の割り出し方

団体名を 成果品に 掲げるこ と	本シートの団体名は公表されている全国集計の行の名称であり、他団体が策定した計画その他の資料によるものではない。成果品に団体名を掲げてよいかをご確認いただきたい（確認事項 No.168）。
得点0の 理由	他団体についても、得点0が「取組がない」のか「要件を満たさない」のかは公表資料から判別できない。得点の差をそのまま取組の差と読まない（確認事項 No.6）。
平均の置 き方	本シートは構成市町村の単純平均を主とし、第1号被保険者数で加重した値を併せて掲げた。構成市町村の数と規模が団体により大きく異なるため、どちらを用いるかで順位が入れ替わる団体がある。

必要項目の洗い出し① 全国の多くの市町村が得点しているのに3町とも0点の項目

令和8年度の明細列299件のうち、全国該当率が45%以上でありながら構成3町のいずれも0点であるものは38列です。大項目にまとめると17群になります。全国該当率は、全国1,741市町村のうち当該列に得点のある市町村の割合です。

① 大項目にまとめたもの（17群）

No	交付金	目標	大項目	0点の列数	配点(1町)	全国該当率%	対応可否	対応する施策	要件の概要（評価指標による）
1	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化事業の取組状況	2	14	61.3～96.9	条件付き	4-3 介護給付費の適正化	主要事業を実施し、結果を活用すること
2	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	4	14	81.1～91.9	条件付き	1-2 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築	日常の療養支援・入退院支援・急変時の対応・看取りの4場面ごとに具体的な取組を行うこと
3	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	事業計画の進捗状況	2	8	75.8～88.0	可	1-1 圏域ビジョン・戦略の推進	計画の進捗状況を分析し、外部の関係者を含む場で検証したうえで公表すること
4	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化方策の策定状況	3	24	62.1～85.3	可	4-3 介護給付費の適正化	計画に適正化の方策・目標を定めること
5	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	評価結果の活用	4	16	50.3～83.1	可	1-1 圏域ビジョン・戦略の推進	評価結果を関係者間で共有し、自立支援等に資する取組を検討すること
6	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	医療・介護関係者間の情報共有	2	10	77.6～80.0	条件付き	1-2 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築	情報共有のツール・様式を整備し運用すること
7	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	アウトリーチ等の取組状況	1	2	78.9～78.9	条件付き	2-1 地域共生社会を目指すしまちづくりの推進	支援を要する高齢者を把握し支援につなぐ仕組みを持つこと
8	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討	3	15	57.1～77.1	可	1-2 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築	医療・介護関係者による会議で課題と対応策を検討し計画に反映すること
9	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域包括支援センター事業評価の達成状況	4	4	51.2～71.0	条件付き	2-6 包括的な支援体制の整備	センターの事業評価を実施し、結果を活用すること
10	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	今年度の評価点	2	6	50.1～70.5	条件付き	1-1 圏域ビジョン・戦略の推進	前年度からの評価点の伸びがあること
11	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	ケアプラン点検の実施状況	2	8	50.0～70.0	条件付き	4-3 介護給付費の適正化	点検を実施し、結果を事業所へ返すこと
12	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	入退院支援の実施状況	3	6	50.0～70.0	条件付き	1-2 在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築	入退院支援のルールを策定し運用すること
13	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	早期診断・早期対応の体制構築	1	5	67.6～67.6	条件付き	2-3 認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進	初期集中支援チームが活動していること
14	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	介護人材の確保・定着の取組状況	1	6	58.2～58.2	条件付き	4-4 人材確保・育成の推進	研修・情報発信・事業所支援を実施すること
15	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	介護予防・生活支援の体制整備	2	4	50.3～53.4	条件付き	2-2 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	協議体を開催し、多様なサービスを創出すること
16	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	1	4	52.9～52.9	条件付き	2-3 認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進	チームオレンジ等の活動の場をつくること

① 大項目にまとめたもの (17群)

17	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	通いの場への参加率	1	1	50.0～50.0	現時点では不可	2-2 介護予防・日常生活支援総合事業の推進	参加率が一定の水準にあること
----	----	----------------------	-----------	---	---	-----------	---------	------------------------	----------------

② 明細列の全件 (38列)

No	交付金	目標	大項目	列	配点(1町)	全国該当率%	3町の得点	対応可否	
1	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化事業の取組状況	ア	6	96.9	0/0/0	条件付き	
2	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	③	2	91.9	0/0/0	条件付き	
3	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	事業計画の進捗状況	イ	4	88.0	0/0/0	可	
4	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	②	2	85.9	0/0/0	条件付き	
5	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化方策の策定状況	イ	8	85.3	0/0/0	可	
6	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	ウ	5	83.5	0/0/0	条件付き	
7	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	評価結果の活用	ア	4	83.1	0/0/0	可	
8	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	エ	5	81.1	0/0/0	条件付き	
9	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	医療・介護関係者間の情報共有	ウ	5	80.0	0/0/0	条件付き	
10	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	アウトリーチ等の取組状況	イ	2	78.9	0/0/0	条件付き	
11	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	医療・介護関係者間の情報共有	エ	5	77.6	0/0/0	条件付き	
12	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討	ウ	5	77.1	0/0/0	可	
13	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化方策の策定状況	ウ	8	76.3	0/0/0	可	
14	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	事業計画の進捗状況	ウ	4	75.8	0/0/0	可	
15	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域包括支援センター事業評価の達成状況	イ①	1	71.0	0/0/0	条件付き	
16	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	今年度の評価点	ア	3	70.5	0/0/0	条件付き	
17	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	評価結果の活用	ウ	4	70.0	0/0/0	可	
18	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	ケアプラン点検の実施状況	ア	4	70.0	0/0/0	条件付き	
19	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	入退院支援の実施状況	ア①	2	70.0	0/0/0	条件付き	
20	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	早期診断・早期対応の体制構築	ウ	5	67.6	0/0/0	条件付き	
21	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	評価結果の活用	イ	4	64.5	0/0/0	可	
22	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化方策の策定状況	エ	8	62.1	0/0/0	可	
23	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化事業の取組状況	ウ	8	61.3	0/0/0	条件付き	
24	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討	オ	5	60.4	0/0/0	可	
25	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域包括支援センター事業評価の達成状況	②	1	59.0	0/0/0	条件付き	
26	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供体制の整備を推進する	介護人材の確保・定着の取組状況	エ	6	58.2	0/0/0	条件付き	
27	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討	エ	5	57.1	0/0/0	可	
28	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域包括支援センター事業評価の達成状況	②	1	54.9	0/0/0	条件付き	
29	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	介護予防・生活支援の体制整備	カ	2	53.4	0/0/0	条件付き	
30	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	エ	4	52.9	0/0/0	条件付き	
31	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域包括支援センター事業評価の達成状況	②	1	51.2	0/0/0	条件付き	
32	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	入退院支援の実施状況	②	2	50.6	0/0/0	条件付き	
33	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたむける	評価結果の活用	エ	4	50.3	0/0/0	可	
34	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	介護予防・生活支援の体制整備	オ	2	50.3	0/0/0	条件付き	

① 大項目にまとめたもの (17群)

35	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかた ちにす	今年度の評価点	イ	3	50.1	0／0／0	条件付き	
36	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築 す	ケアプラン点検の実施状況	イ	4	50.0	0／0／0	条件付き	
37	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	通いの場への参加率	②	1	50.0	0／0／0	現時点では不可	
38	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構 築す	入退院支援の実施状況	②	2	50.0	0／0／0	条件付き	

【読み取り】全国該当率が70％以上のもの（全国の7割以上の市町村が得点しているもの）が19列あります。最も高いのは推進 給付費適正化事業の取組状況 ア（96.9％）で、次いで支援 在宅医療・介護連携の具体的取組状況 ③（91.9％）です。得点0が「取組がない」のか「取組はあるが要件を満たさない」のかは公表資料から判別できません（確認事項No.6）。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するもので、得点のみを理由とするものではありません。

必要項目の洗い出し② 構成3町のうち一部の町のみ得点している項目

同じ広域連合を構成する3町は制度・保険者が同じであり条件がそろっています。得点が分かれている項目は、既に実施している町の取組を区域内で広げることと得点に結びつく余地があるものです。明細列299件のうち78列が該当します。

① 町別にみた伸びしろ（得点していない列の配点の合計）

町	令和8年度の 得点	区域内で他の町が得点している列	その配点の合計	該当率45% 以上)で0点	その配点の合計						
東川町	315	56	109	85	240						
美瑛町	308	50	116	83	254						
東神楽町	379	14	45	49	184						

配点の合計は、当該列をすべて得点した場合の上限です。実際には要件を満たす必要があり、そのまま得点になるものではありません。また同じ列が両方の欄に現れることはありません（区域内で分かれている列は、その町以外が得点しているため3町とも0点の列には入りません）。

② 配点の大きいもの（上位40列）

No	交付金	目標	大項目	列	配点(1町)	全国該当率%	東川	美瑛	東神楽	得点している町	見方
1	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化事業の取組状況	オ	8	65.1	0	8	8	美瑛町・東神楽町	町により得点する列が異なる。東川町は2列とも0点
2	推進	目標Ⅱ 公正・公平な給付を行う体制を構築する	給付費適正化事業の取組状況	エ	8	47.3	0	8	0	美瑛町	町により得点する列が異なる。東川町は2列とも0点
3	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	医療・介護関係者間の情報共有	イ	6	91.1	0	0	6	東神楽町	東神楽町の仕組みを区域内に広げる余地
4	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	庁内・庁外における連携体制	ア	6	87.8	6	0	6	東川町・東神楽町	町により得点する列が異なる
5	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	介護人材の確保・定着の取組状況	ア	6	83.4	6	0	6	東川町・東神楽町	町により得点する列が異なる
6	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	介護人材の確保・定着の取組状況	イ	6	76.6	6	6	0	東川町・美瑛町	町により得点する列が異なる
7	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	庁内・庁外における連携体制	オ	6	46.1	6	0	6	東川町・東神楽町	町により得点する列が異なる
8	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	庁内・庁外における連携体制	エ	6	43.1	0	6	0	美瑛町	町により得点する列が異なる
9	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	早期診断・早期対応の体制構築	エ	5	74.5	0	0	5	東神楽町	美瑛町の初期集中支援は医師を確保できず休止中
10	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	難聴高齢者の早期発見・早期介入	ア	5	68.9	5	0	5	東川町・東神楽町	令和8年度に新設された項目。美瑛町のみ0点
11	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	難聴高齢者の早期発見・早期介入	イ	5	48.8	5	0	5	東川町・東神楽町	令和8年度に新設された項目。美瑛町のみ0点
12	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	ア	4	87.0	4	0	0	東川町	町により得点する列が異なる。3町で取組の内容が違う
13	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	イ	4	78.1	0	4	4	美瑛町・東神楽町	町により得点する列が異なる。3町で取組の内容が違う
14	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	ウ	4	75.6	4	0	0	東川町	町により得点する列が異なる。3町で取組の内容が違う
15	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症地域支援推進員の業務の状況	ア	3	70.5	3	0	3	東川町・東神楽町	
16	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症地域支援推進員の業務の状況	イ	3	70.5	3	0	3	東川町・東神楽町	
17	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター数	ア	3	70.0	0	3	0	美瑛町	
18	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	後期高齢者と給付費の伸び率比較	ア	3	69.9	3	0	3	東川町・東神楽町	
19	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	介護支援専門員に対する研修の実施状況	ア	3	66.9	3	0	0	東川町	
20	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	後期高齢者と給付費の伸び率比較	イ	3	50.0	3	0	3	東川町・東神楽町	
21	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症サポーター数	イ	3	50.0	0	3	0	美瑛町	
22	支援	目標Ⅱ 認知症総合支援を推進する	認知症地域支援推進員の業務の状況	ウ	3	46.2	0	0	3	東神楽町	
23	推進	目標Ⅰ 持続可能な地域のあるべき姿をかたちにする	後期高齢者と給付費の伸び率比較	ウ	3	30.0	3	0	3	東川町・東神楽町	
24	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	イ①	2	92.9	0	2	0	美瑛町	

① 町別にみた伸びしろ（得点していない列の配点の合計）

25	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	介護予防等と保健事業の一体的実施	エ	2	87.4	0	0	2	東神楽町	
26	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	データを活用した課題の把握	ウ	2	83.4	0	2	2	美瑛町・東神楽町	
27	推進	目標Ⅲ 介護人材の確保その他のサービス提供基盤の整備を推進する	庁内・庁外における連携体制	④	2	83.2	0	2	2	美瑛町・東神楽町	町により得点する列が異なる
28	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	通いの場参加者の健康状態の把握・分析	イ	2	82.7	2	0	2	東川町・東神楽町	
29	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	介護予防等と保健事業の一体的実施	ウ	2	82.4	2	0	2	東川町・東神楽町	
30	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域リハビリテーションの推進	イ	2	81.8	0	2	2	美瑛町・東神楽町	
31	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域リハビリテーションの推進	ウ	2	75.9	0	0	2	東神楽町	
32	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	データを活用した課題の把握	エ	2	74.4	0	0	2	東神楽町	
33	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	通いの場参加者の健康状態の把握・分析	オ	2	71.2	0	0	2	東神楽町	
34	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	人生の最終段階における支援の実施状況	ア ①	2	70.0	0	0	2	東神楽町	
35	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	人生の最終段階における支援の実施状況	イ ①	2	70.0	2	0	2	東川町・東神楽町	
36	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	アウトリーチ等の取組状況	エ	2	65.9	0	0	2	東神楽町	
37	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	介護予防・生活支援の体制整備	エ	2	61.2	0	2	0	美瑛町	
38	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	人生の最終段階における支援の実施状況	②	2	50.1	0	0	2	東神楽町	
39	支援	目標Ⅲ 在宅医療・在宅介護連携の体制を構築する	人生の最終段階における支援の実施状況	②	2	50.1	0	0	2	東神楽町	
40	支援	目標Ⅰ 介護予防/日常生活支援を推進する	地域リハビリテーションの推進	エ	2	47.7	0	0	2	東神楽町	

【読み取り】78列のうち配点の大きい上位40列を掲げました。残る38列は配点1～2点のものです。得点している町があるということは、その取組が当区域の条件で実施できることを示します。ただし町の規模・体制・地域資源の違いによりそのまま広げられないものもあるため、3町協議の場で実施の可否を伺います（10月の町別協議、確認事項No.159～No.167）。

対応可否の判定（07シートの17群）

全国の多くの市町村が得点しているのに3町とも0点である17群について、第10期計画の期間に対応できるかどうかを判定したものです。判定は受託者によるものであり、ご確認をお願いします。第10期の施策に位置づけるかどうかは取組の必要性から判断するもので、得点のみを理由とするものではありません。

No	交付金	大項目	0点の列	配点(1町)	判定	判定の理由	決定・受領を要するもの	確認事項	計画案の反映先
1	推進	給付費適正化事業の取組状況	2	14	条件付き	介護給付費通知・認定調査状況チェック・医療情報との突合の実施の状況によって決まる。区域内でも美瑛町のみ得点している列があり、3町で実施の状況が異なる。	介護給付費通知の実施状況（No.91）、認定調査の委託の状況（No.92）。	No.91・No.92	第5章 基本目標5（3）施策の方向性・資料5
2	支援	在宅医療・介護連携の具体的取組状況	4	14	条件付き	日常の療養支援・入退院支援・急変時の対応・看取りの4場面ごとに具体的な取組を行うことが要件である。全国該当率が81.1～91.9％と高く、多くの市町村が得点している一方、3町はいずれも0点である。	3町の在宅医療・介護連携推進事業の実績（資料提供依頼No.13）。	No.61	第5章 基本目標1 第2章第2節
3	推進	事業計画の進捗状況	2	8	可	計画の進捗状況を分析し、外部の関係者を含む場で検証して公表することが要件である。計画素案 第1章第6節に進行管理の手順を定めており、第10期の初年度から運用できる。	追加の資料を要しない。	No.71（了承済）	第5章 基本目標1 第1章第6節
4	推進	給付費適正化方策の策定状況	3	24	可	計画に適正化の方策と定量目標を定めることが要件である。第7期給付適正化計画として計画素案 第5章 基本目標5（3）及び資料5に位置づけ、主要3事業の毎年度の定量目標を掲げている。	追加の資料を要しない。	No.72（了承済）	第5章 基本目標5（3）施策の方向性・資料5
5	推進	評価結果の活用	4	16	可	評価結果を関係者間で共有し、自立支援等に資する取組を検討することが要件である。評価結果は策定委員会（運営協議会）の資料として整理している。委員会に諮った記録を残すことで要件を満たす。	追加の資料を要しない。	No.71（了承済）	第5章 基本目標1 第1章第6節
6	支援	医療・介護関係者間の情報共有	2	10	条件付き	情報共有のツール・様式を整備して運用することが要件である。区域内では東神楽町が1列で得点しており、横展開の余地がある。	東神楽町の情報共有の仕組みの内容。	No.61	第5章 基本目標1 第2章第2節
7	支援	アウトリーチ等の取組状況	1	2	条件付き	支援を必要とする高齢者を把握し支援につなぐ仕組みの有無で決まる。区域内では東神楽町のみ得点している列がある。	3町の地域包括支援センターの実施の状況。	No.61	第5章 基本目標2
8	支援	在宅医療・介護連携に関する課題・対応策の検討	3	15	可	医療・介護関係者による会議で課題と対応策を検討し、計画に反映することが要件である。計画素案 第5章 基本目標1 施策1-2に位置づけている。検討の場を設けて記録を残すことで要件を満たす。	追加の資料を要しない（実施主体の決定を要する）。	No.61	第5章 基本目標1 第2章第2節
9	支援	地域包括支援センター事業評価の達成状況	4	4	条件付き	センターの事業評価を実施し結果を活用することが要件である。総合事業の実施状況に関する調査により、一般介護予防事業評価事業及び総合事業の事業評価は3町とも実施していない。実施すれば得点に結びつく。	3町の事業評価の実施の意向。	No.5・No.61	第5章 基本目標1 第3章第2節
10	推進	今年度の評価点	2	6	条件付き	前年度からの得点の伸びを評価するものであり、他の項目の改善の結果として決まる。単独で取りにくい項目ではない。	追加の資料を要しない。	No.70	第5章 基本目標1 第1章第6節
11	推進	ケアプラン点検の実施状況	2	8	条件付き	点検の実施件数と結果の活用が要件である。計画素案 第5章 基本目標5（3）に着手を掲げているが、実施要領が未確定である。	ケアプラン点検実施要領（案）の確定（No.73）。	No.72・No.73	第5章 基本目標5（3）施策の方向性・資料5

No	交付金	大項目	0点の列	配点(1町)	判定	判定の理由	決定・受領を要するもの	確認事項	計画案の反映先
12	支援	入退院支援の実施状況	3	6	条件付き	入退院支援のルールを策定し運用することが要件である。令和8年度に6点（3町計）まで回復したが、なお0点の列が3つある。	3町と医療機関との入退院支援ルールの有無。	No.61	第5章 基本目標1 第2章第2節
13	支援	早期診断・早期対応の体制構築	1	5	条件付き	認知症初期集中支援チームの活動の状況によって決まる。美瑛町は令和7年度の実績が0件であり、医師を確保できず休止中である旨が報告されている。東神楽町は当該列で得点している。	美瑛町のチーム員会議の再開の見通し。	No.150・No.162	第5章 基本目標2 第1章第2節・第1章第8節
14	推進	介護人材の確保・定着の取組状況	1	6	条件付き	研修・情報発信・事業所支援の実施の状況によって決まる。区域内でも町により得点か分かれている。	3町の令和7・8年度の取組の状況（資料提供依頼No.13）。	No.61	第5章 基本目標4 第2章第6節
15	支援	介護予防・生活支援の体制整備	2	4	条件付き	協議体の開催と多様なサービスの創出の状況によって決まる。令和6年度から令和8年度にかけて3点下がっている。	3町の協議体の開催状況と生活支援体制整備事業の実績。	No.5	第5章 基本目標2 第3章第2節
16	支援	認知症サポーター等を活用した地域支援体制の構築	1	4	条件付き	チームオレンジ等の活動の状況によって決まる。東川町は令和7年3月にチームオレンジ結成会を開催し、令和8年度計画にチームオレンジ事業を新たに立てている。区域内で横展開の余地がある。	3町のサポーター養成講座・ステップアップ講座の実施状況（No.160・No.167）。	No.160・No.167	第5章 基本目標2 第1章第2節・第1章第8節
17	支援	通いの場への参加率	1	1	現時点では不可	参加率の水準による指標である。総合事業ベースの参加率は令和6年度3.53％であり、当該列の要件に届かない。施策としては基本目標2に位置づけているが、単年度で届く水準ではない。	追加の資料を要しない。	No.61	第5章 基本目標2 第3章第2節

判定の内訳

判定	件数	意味	第10期での扱い						
可	4	追加の資料を受領しなくても、計画に定め運用することで要件を満たせるもの。	計画素案に既に位置づけているもの、又は進行管理の手順とし						
条件付き	12	3町の取組の状況の確認、又は実施要領等の決定を要するもの。	10月の3町協議で実施の可否を伺い、第2次概算（10月30日）						
現時点では不可	1	参加率等の水準による指標であり、単年度で要件に届かないもの。	施策としては位置づけますが、計画期間中の得点を見込みませ						

【注】判定は令和8年度の評価指標によるものです。評価指標は毎年度見直しされ、令和9年度の指標は未公表です。また令和8年度には成果指向型配分枠（配点100点）が新設されており（確認事項No.69）、その対応は本表では扱っていません。

計画素案・協議資料・確認事項との紐付け

交付金の評価項目を第9期計画の19施策に割り当て、施策ごとに計画素案の反映先・10月の協議資料・確認事項と対にしたものです。割当ては受託者によるものです（確認事項No.61）。得点率は3町計の得点を3町計の配点で除したもので、成果指標群を含む施策は達成度として読めません。

施策	施策名	項目数	配点(3町計)	R6得点	R8得点	R6→R8	計画素案の反映先	10月の協議資料	関係する確認事項	対応状況
1-1	圏域ビジョン・戦略の推進	5	228	100	100	+0	第5章 基本目標1 第1章第6節	40件の確認事項のうち共通24件	No.6・No.70・No.71	進行管理の手順を計画素案 第1章第6節に定め、評価結果は策定委員会資料として整理している（No.71 了承済）
1-2	在宅療養者支援に向けた医療機関との連携体制の構築	5	300	71	91	+20	第5章 基本目標1 第2章第2節	地域課題 医療・介護連携	No.61	3町とも0点の明細列が12ある。素案 第5章 基本目標1に位置づけているが、具体的取組の実績が未受領
1-3	高齢者の状況に応じたサービスの提供	2	60	21	18	-3	第5章 基本目標3 第2章第3節・第6章第4節	地域課題 サービス提供体制	No.84・No.88	素案 第2章第3節・第6章第4節に反映済み
1-4	高齢者の虐待防止の推進	—	—	—	—	—	第5章 基本目標1	—	—	交付金に該当する項目がない。業務記録から把握する仕組みを要する
2-1	地域共生社会を目指したまちづくりの推進	4	78	32	39	+7	第5章 基本目標2	地域課題 包括的支援体制	No.5	生活支援コーディネーターの地域ケア会議への参加は令和8年度に3町とも満点
2-2	介護予防・日常生活支援総合事業の推進	5	123	42	32	-10	第5章 基本目標2 第3章第2節	地域課題 通いの場	No.5・No.166	通いの場は箇所数 東川2・美瑛8・東神楽15。素案 第3章第2節・第5章 基本目標2に反映済み
2-3	認知症施策推進大綱を踏まえた施策の推進	6	300	74	89	+15	第5章 基本目標2 第1章第2節・第1章第8節	認知症施策推進計画（07・08シート）	No.130・No.149・No.150・No.160・No.162・No.165・No.167	案Bを採用し素案4箇所に反映済み。町により得点が分かれる項目が多い
2-4	高齢者の住まいと生活支援の一体化支援に向けた検討	—	—	—	—	—	第5章 基本目標3	—	—	交付金に該当する項目がない。居所変更実態調査による
2-5	地域ケア会議の推進	2	24	14	21	+7	第5章 基本目標2 第2章第7節	地域課題 地域ケア会議	No.118・No.121	代表KPI O2の基準値がなお把握できていない
2-6	包括的な支援体制の整備	2	48	14	11	-3	第5章 基本目標1 第3章第2節	地域課題 包括的支援体制	No.5	センターの事業評価は3町とも実施していない
3-1	高齢者による主体的な健康づくり・介護予防の推進	4	78	44	39	-5	第5章 基本目標2	地域課題 健康づくり	No.5	素案 第5章 基本目標3に位置づけ
3-2	地域リハビリテーション支援体制の構築	1	21	10	10	+0	第5章 基本目標2	地域課題 リハビリテーション	No.163	地域リハビリテーション活動支援事業は美瑛町のみ実施
3-3	高齢者の保健事業・介護予防の一体化の推進	2	39	26	26	+0	第5章 基本目標2	地域課題 保健事業との一体化	No.5	KDBの活用は美瑛町・東神楽町の2町
3-4	地域支援事業の連動性の確保	2	51	15	15	+0	第5章 基本目標2	地域課題 地域支援事業	No.112	地域支援事業の量の見込みを素案 第6章第3節2に加えた
4-1	介護サービスの生産性向上	2	192	120	118	-2	第5章 基本目標4	地域課題 生産性向上	No.95	生産性向上委員会は令和9年4月1日に義務となる（対象15事業所）
4-2	介護サービス事業者の適正・円滑な運営	—	—	—	—	—	第5章 基本目標4	—	—	交付金に該当する項目がない

施策	施策名	項目数	配点(3町計)	R6得点	R8得点	R6→R8	計画素案の反映先	10月の協議資料	関係する確認事項	対応状況
4-3	介護給付費の適正化	4	300	70	114	+44	第5章 基本目標5 (3) 施策の方向性・資料5	地域課題 給付適正化	No.72・No.73・No.91・No.92・No.93	第7期給付適正化計画として素案 第5章 基本目標5 (3)・資料5に位置づけ済み (No.72 了承済)
4-4	人材確保・育成の推進	4	198	51	45	-6	第5章 基本目標4 第2章第6節	地域課題 介護人材	No.61	素案 第2章第6節・第5章 基本目標4に反映済み
5-1	災害や感染症対策に係る体制整備	—	—	—	—	—	第5章 基本目標5	—	—	交付金に該当する項目がない

確認事項の状態

No	確認事項	確認先	状態	回答期限	本表との関係					
6	交付金の評価調書	発注者	確認待ち	R8.9	得点0の理由（取組がない／要件を満たさない） 交付金の評価項目と19施策の割当て（10シート） 成果指向型配分枠（本表では扱っていない） 全国での位置の計画本文への掲載					
61	交付金の評価項目と19施策の割当て	発注者	確認待ち	R8.9						
69	成果指向型配分枠（令和8年度新設）への対応	発注者	確認待ち	R8.10						
70	交付金の全国順位の計画本文への掲載	発注者	確認待ち	R8.9						
71	交付金の評価結果を委員会資料として整理したこと	発注者	了承済	R8.9.3	評価結果を策定委員会資料として整理すシート					
86	保険者機能強化推進交付金等の交付見込額の保険料収納必要額からの控除	発注者	確認待ち	R8.10	交付見込額の保険料収納必要額からの控除（＝					
93	財政調整交付金の算定における給付適正化主要3事業の取組状況の勘案	発注者・北海道	確認待ち	R8.10	財政調整交付金への給付適正化主要3事業の認知症総合支援事業の実績					
150	認知症総合支援事業の実績のご提供	発注者	一部確認済み	R8.10						
168	同様の構成の団体との比較（団体名の掲載と令和7年度の内訳）	発注者	一部確認済み	R8.10	北海道内の同様の構成の団体の得点の抽出（06					
169	構成町により得点に分かれている項目の区域内での取扱い	発注者・3町	確認待ち	R8.10	区域内で得点に分かれている項目の3町統一の					

自己点検

本表の内的整合の点検です。1件でも不適合があると作成が終了コード1で終わります。

No	点検の内容	結果	判定
1	大項目の得点の合計が公表の推進・支援合計と一致すること（令和8年度）		適合
2	明細列の得点の合計が大項目の得点の合計と一致すること（令和8年度）		適合
3	大項目を名で突き合わせていること（年度により並び順が異なるため）	令和6年度にあって令和8年度にない項目1件・新設1件	適合
4	改善・低下・横ばい・新設の合計が大項目数と一致すること	14 + 14 + 24 + 1 = 53	適合
5	3町とも0点で全国該当率45 %以上の明細列がすべて大項目に束ねられていること	38列→17群	適合
6	17群のすべてに対応可否の判定があること	判定なし0件	適合
7	判定の内訳の合計が群の数と一致すること	可4・条件付き12・不可1 = 17	適合
8	判定で参照する施策IDがすべて施策名の一覧にあること		適合
9	区域内で分かれている列と3町とも0点の列が重ならないこと	重複0列	適合
10	全国での位置が3か年とも収録されていること		適合
11	本表が参照する確認事項がすべて業務工程管理表にあること	見当たらないものなし	適合
12	新たに起票した確認事項No.168・No.169が業務工程管理表にあること		適合
13	確認事項の番号に欠番・重複がないこと	No.1～169・169件	適合
14	計画素案の反映先として挙げた章節が素案に実在すること		適合
15	施策と交付金項目の割当てが令和8年度の大項目の名で解決できること	解決できないもの0件	適合
16	全国集計の対象市町村数が3か年とも1,741であること		適合
17	3町の得点がほぼ横ばいである一方、全国平均が上がっていること	3町平均+2.0点・全国平均+32.5点	適合
18	本表に担当者名・電話番号・メールアドレスを含まないこと		適合
19	禁止表現を含まないこと	見つかったものなし	適合
23	広域連合・一部事務組合の行に得点がないこと	38団体	適合
24	構成市町村の数が全国集計の行数と整合すること	1,741（得点のある行）+ 38（団体の行） = 1779	適合
25	当連合の構成市町村が東川町・美瑛町・東神楽町であること	東川町・美瑛町・東神楽町	適合
26	当連合の構成市町村の得点が収録値と一致すること（令和8年度）		適合
27	当連合の構成市町村の得点が収録値と一致すること（令和6・7年度）		適合
30	3か年とも38団体の構成市町村が同じであること	令和6年度のみの団体2件	適合
31	当連合の令和6年度の平均が3町平均と一致すること	332.0	適合
28	当連合の平均が3町平均と一致すること	334.0	適合
29	団体の順位づけに重複・欠落がないこと	全38団体・町村のみ11団体・北海道4団体	適合
21	19施策のすべてに第10期の基本目標の対照があること	対照のないものなし	適合
22	介護給付費の適正化が第10期の基本目標5に移ることを反映していること	施策4-3→第5章 基本目標5	適合
20	受託者の内部の仕組みの語を本文に書いていないこと		適合